

Ondergetekende Dr. WOSTYN Lieven, specialist in de verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise, en consulent Centrum voor Gerechtelijke Geneeskunde UZA, aangesteld als ARTS-GERECHTSDISKUNDIGE, **EXP2165726**, bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, K.16 gewezen op **18 november 2024**,

BURGERLIJKE PARTIJ

Evelyne DELTOUR

geboren op 31 maart 1979 te Roeselare,
van Belgische nationaliteit,
ingeschreven te Jozef Delbaerestraat 1, 8800 Roeselare

vertegenwoordigd door meester Julie VANDENBOGAERDE, advocaat te Kortrijk.

TEGEN BEKLAAGDE

Jan FIEUW

geboren op 1 april 1977 te Roeselare,
van Belgische nationaliteit,
ingeschreven te Zuidmolenstraat 3, 8800 Roeselare.

vertegenwoordigd door meester Laure VERVAEKE, advocaat te Kortrijk.

MET ALS OPDRACHT :

1. kennis te nemen van het strafdossier K04312.300/2024 en de medische stukken hem door partijen te bezorgen;
2. partijen per aangetekend schrijven en hun eventuele raadslieden per gewone post te verwittigen van de plaats, de dag en het uur van het deskundigenonderzoek;
3. zo dit nodig mocht blijken in de loop van het onderzoek, de gepaste specialisten te consulteren en hun advies en zijn oordeel desbetreffende bij het verslag te voegen;
4. de aard van de letsels (fysiek en psychisch) en de eventueel ondergane behandelingen te beschrijven en na te gaan of deze letsels in oorzakelijk verband staan met de feiten waarvoor de beklaagde werd veroordeeld;
5. zijn oordeel te geven nopens de aard, de duur en de evolutie van het genezingsproces en, in voorkomend geval, de duur van de hospitalisatie, alsook over de ernst van de geleden pijnen;

6. zijn advies te geven over de duur en de graden van de tijdelijke persoonlijke, huishoudelijke en economische ongeschiktheid;
7. zijn advies te geven over de graden van de blijvende persoonlijke, huishoudelijke en economische ongeschiktheid, de weerslag ervan op de beroepsactiviteit en/of op de andere levenssferen van het slachtoffer, hierbij rekening houdend met zowel de eventuele vooraf bestaande toestand als met het beroep van het slachtoffer;
8. zijn advies te geven over het tijdstip waarop het slachtoffer redelijkerwijs, weze het gedeeltelijk, zijn professionele en andere activiteiten kon hernemen en aan te geven of deze herneming van de activiteiten al dan niet met het leveren van meerinspanningen gepaard ging;
9. de datum van de consolidatie vast te stellen;
10. te bepalen of hulp van derden nodig is in de huishouding of daarbuiten, rekening houdend met de bestaande en beschikbare hulpmiddelen;
11. vast te stellen of de opgelopen letsels na de consolidatie nog medicatie en/of medische of paramedische behandelingen noodzakelijk of louter op comfort gericht zijn; desgevallend de aard en de termijn ervan te bepalen en de omvang van de eraan verbonden kosten te ramen; bij prothesen de noodzakelijke vernieuwingen te bepalen;
12. de gebeurlijke esthetische schade te beschrijven en zo mogelijk te bepalen volgens de gebruikelijke zevendelige schaal, bij voorkeur geïllustreerd door fotomateriaal; de eventuele weerslag van de esthetische schade op de uitoefening van de beroepsactiviteit te beschrijven;
13. advies te verstrekken over eventuele genoegenschade;
14. advies te verstrekken over eventuele seksuele schade;
15. te antwoorden op alle nuttige en ter zake dienende vragen die hem door de betrokken partijen worden gesteld.

Bepaalt dat dit vonnis door de griffier binnen de vijf dagen bij gerechtsbrief ter kennis zal worden gebracht aan de deskundige en per gewone brief aan de partijen en hun raadslieden.

Bepaalt dat de deskundige beschikt over een termijn van acht dagen na de kennisgeving van dit vonnis, om desgewenst de opdracht met behoorlijk omklede redenen te weigeren (artikel 972, §1, derde lid Ger.W.).

Bepaalt dat de deskundige en de partijen zich naar aanleiding van het deskundig onderzoek dienen te gedragen naar de bepalingen van de artikelen 962 tot 991bis Ger.W.

Stelt vast dat niet alle partijen om een installatievergadering hebben verzocht en acht een installatievergadering niet noodzakelijk.

Bepaalt dat als volgt moet worden gehandeld:

de voornoemde deskundige dient alle correspondentie aan de partijen aangetekend, en aan hun raadslieden, alsook aan de verder in onderhavig vonnis met de opvolging en controle van de deskundige werkzaamheden aangewezen rechter, per gewone brief te versturen. Voor wat betreft de correspondentie te voeren na de mededeling van de plaats, de dag, en het uur van de aanvang van de deskundige werkzaamheden, (met uitzondering wat betreft de mededeling van het eindverslag, waarover verder meer) kan de deskundige eventueel door de partijen worden vrijgesteld van de verplichting om per aangetekende post te corresponderen;

- de deskundige dient binnen een termijn van acht dagen na de kennisgeving van dit vonnis —en voor zover hij de opdracht niet weigert — de partijen, hun raadslieden evenals de verder in huidig vonnis met de opvolging en controle van de deskundige werkzaamheden aangewezen rechter schriftelijk op de hoogte te brengen van zijn aanvaarding van de opdracht;
- samen met de hiervoor vermelde schriftelijke kennisgeving van aanvaarding van de opdracht, maakt de deskundige aan dezelfde geadresseerden schriftelijk een raming over van de algemene kostprijs van het deskundigenonderzoek of minstens van de manier waarop en de tarieven waaraan zijn kosten en ereloon, alsook de kosten en het ereloon van de eventuele technische raadgevers zullen berekend worden;
- de deskundige dient daarna te wachten op de kennisgeving van de consignatie van het voorschot door de griffier, zoals verder in onderhavig vonnis bepaald;

binnen een termijn van vijftien dagen nadat hem door de griffier werd kennis gegeven van de consignatie van het voorschot, dient de deskundige zelf de plaats, de dag, en het uur te bepalen waarop hij zijn werkzaamheden zal aanvatten. Binnen dezelfde voormelde termijn dient hij die gegevens schriftelijk aan de partijen, hun

raadslieden en aan de rechter mede te delen;

de partijen dienen ten laatste acht dagen voor de eerste bijeenkomst bij de deskundige een geïnventariseerd dossier met alle relevante stukken aan de voornoemde deskundige over te maken, conform artikel 972bis, §1, tweede lid Ger.W. (en deze op hetzelfde voormelde ogenblik eveneens mede te delen aan alle wederpartijen —voor zover dit nog niet vroeger zou gebeurd zijn);

- de deskundige zal in de loop van zijn opdracht zelf bepalen of het noodzakelijk is om al dan niet een beroep te doen op technische raadgevers;
- alle verrichtingen dienen tegensprekelijk te gebeuren en alle partijen dienen opgeroepen te worden om daar deel aan te nemen, tenzij de partijen de deskundige hiervan zouden vrijstellen gelet op het uiterst technische karakter van sommige verrichtingen;

zegt dat de beklaagde de verrichtingen van de deskundige niet in persoon mag bijwonen, maar wel een geneesheer naar keuze mag aanstellen om de expertise bij te wonen, onveranderd zijn recht op vertegenwoordiging door een advocaat;

- de minuut van het met redenen omkleed eindverslag, opgemaakt overeenkomstig de wettelijke voorschriften krachtens artikel 978, § 1 Ger.W., dient, samen met de gedetailleerde staat van kosten en ereloon van de deskundige (en eventueel geraadpleegde technische raadgever(s)), conform artikel 990 Ger.W., neergelegd te worden op de correctionele griffie van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, met afschrift per aangetekend schrijven aan partijen en per gewone brief aan de raadslieden.
- het eindverslag dient door de deskundige op straffe van nietigheid te worden ondertekend en afgesloten met de wettelijke eedformule: "Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk zal vervullen".

BEVESTIGT :

deze opdracht te hebben vervuld, en behoorlijk de partijen te hebben verwittigd van de plaats, dag en uur van het deskundig onderzoek, meer bepaald :

In het kabinet van ondergetekende, Lostraat 10 te Aalter, op **maandag 3 februari 2025 om 13 uur**, deze zitting werd verdaagd;

In het kabinet van ondergetekende, Lostraat 10 te Aalter, op **vrijdag 7 maart 2025 om 12 uur**;

In het kabinet van ondergetekende, Lostraat 10 te Aalter, op **vrijdag 14 maart 2025 om 9 uur**, deze zitting werd verdaagd.

Waren aanwezig op deze zitting:

Evelyne DELTOUR – slachtoffer

Dr. Jan GODDYN – raadsgeneesheer

Dr. Lieven WOSTYN – gerechtsdeskundige

Fien DESART – administratief medewerker

Tijdens deze zittingen werden de personalia, de persoonlijke anamnese, de medische antecedenten, en de beschrijving van de feiten en de evolutie van de letsels na de feiten doorgenomen, inzonderheid in welke mate de duur van de ongeschiktheid in causaal verband met het ongeval staat.

Er werd een klinisch onderzoek uitgevoerd.

INVENTARIS EN VERLOOP VAN DE VERRICHTINGEN

1. Schrijven ontvangen d.d. 28 november 2024 van mevrouw de griffier E. DE ROOSE met in bijlage vonnis aanstelling deskundige;
2. Schrijven d.d. 28 november 2024 gericht aan partijen (aangetekend) en raadslieden (gewoon) met mededeling aanvaarden opdracht en vraag naar alle nuttige medische stukken en gegevens raadsgeneesheer;
3. Schrijven (mail) d.d. 30 november 2024 ontvangen van de tegenpartij de heer FIEUW met vraag of het causaal verband onderzocht zal worden tussen de geweldpleging en de psychische toestand van betrokkene en vraag of hij de conclusies mag afwachten en later kan beslissen of hij al dan niet beroep zal doen op een raadsgeneesheer;
4. Provisie ontvangen op 13 december 2024;
5. Schrijven d.d. 13 januari 2025 gericht aan partijen (aangetekend) en raadslieden (gewoon) met mededeling plaats- en datum (eerste) expertisезitting;

6. Schrijven (mail) d.d. 28 januari 2025 ontvangen van Meester VANDENBOGAERDE met mededeling dat betrokkene zich zal laten bijstaan door de heer Jan GODDYN en de geplande expertisезitting niet door zal kunnen gaan;
7. Schrijven d.d. 31 januari 2025 gericht aan partijen (aangetekend) en raadslieden (gewoon) met mededeling plaats- en datum (eerste) expertisезitting;
8. (Eerste) expertisезitting op maandag 3 februari 2025, deze zitting werd verdaagd;
9. Schrijven (mail) d.d. 7 februari 2025 ontvangen van Meester VANDENBOGAERDE met mededeling dat betrokkene aanwezig zal zijn op de geplande zitting van 7 maart 2025;
10. Schrijven (mail) d.d. 3 maart 2025 ontvangen van Meester VANDENBOGAERDE met ingesloten het verslag van de heer GODDYN;
11. (Eerste) expertisезitting op vrijdag 7 maart 2025 om 12 uur,
12. (Eerste) expertisезitting op vrijdag 14 maart 2025 om 9 uur, deze zitting werd verdaagd;
13. Overmaken voorverslag op 17 maart 2025.

INHOUDSOPGAVE

1. PERSONALIA	8
2. MEDISCHE EN ANDERE ANTECEDENTEN	8
3. FEITEN, LETSELS EN BEHANDELING	9
4. HUIDIGE KLACHTEN EN KLINISCH ONDERZOEK	12
4.1. KLINISCH ONDERZOEK.....	12
4.1.1. Klinisch onderzoek CWZ	13
4.1.2. Klinisch onderzoek bovenste ledematen	13
4.1.3. Klinisch onderzoek dorsale en lumbale wervelzuil	14
4.1.4. Klinisch onderzoek onderste ledematen.....	14
5. ALGEMEEN LOCOMOTORISCH ONDERZOEK	14
6. ALGEMEEN PSYCHIATRISCH ONDERZOEK.....	15
7. BESPREKING:	15
8. BESLUIT:	21

1. PERSONALIA

Evelyne DELTOUR

Huidig beroep:

Handelsvertegenwoordiger bij Dupont Sanitair te Roeselare.

Opleiding:

Logopedie

Voorgaande beroepen:

Betrokkene was samen met ex-partner zaakvoerder van "Kids&Co", een kinderspeciaalzaak in de Westlaan te Roeselare. Deze zaak ging failliet.

Familiaal

Alleenstaand, gescheiden, drie kinderen (20, 17 en 14 jaar oud) thuiswonend.

Vrijetijd

Sporten, lezen, koken en werken.

2. MEDISCHE EN ANDERE ANTECEDENTEN

Medische antecedenten

Ziektes:	Geen ziektes of allergieën gemeld
Operaties:	Kruisbanden knie Drie maal sectio
Chronische medicatie:	Voor de feiten nam betrokkene geen medicatie. Sedert de feiten: Trazodone 25mg (voor het slapen gaan) en Escitalopram.
Psychiatrie:	Op heden tweewekelijks consult bij psycholoog Joke HELLIN (zie hieronder meer). Zij luistert vooral en biedt inzichten die betrokkene zelf niet heeft door verdriet en angst. Nooit bij een psychiater geweest.
Gewicht:	60 kg

Lengte: 1 m 63

3. FEITEN, LETSELS EN BEHANDELING

Op **7 januari 2024** werd betrokkene het slachtoffer van slagen- en verwondingen, toegebracht door diens ex-man.

De ex-man van betrokkene drong haar woning binnen te Rumbeke. Zij werd vervolgens geheel onverwachts en op brutale wijze fysiek aangevallen. Betrokkene was aan het eten toen de bel ging, ze deed de deur open en haar ex-man drong direct binnen en begon betrokkene te slaan, betrokkene struikelde naar achteren, de dader zat op haar. Het geweld stopte pas bij tussenkomst van een derde, de toenmalige partner van betrokkene. Hij heeft de dader toen buitengezet. De dader was onder invloed van alcohol. De aanval kwam geheel onverwachts en duurde volgens betrokkene slechts een vijftal minuten.

Op **7 januari 2024** werd betrokkene gezien op de spoedgevallendienst van de St-Jozefs kliniek Izegem door Dr. P VAN DE SIJPE. Wonde dicht geniet. Verslag ontbreekt.

Op **10 januari 2024** werd psychologische begeleiding voorgeschreven door huisarts Dr. E. UYTTERSROT.

Op **15 augustus 2024** werd betrokkene opgenomen op de dienst spoedgevallen, uitgelokt door stress. Zij kon niets meer onthouden, vroeg meermaals hetzelfde en vergat alles. Uit onderzoek bleek dat zij een TGA (*transient global amnesia*)¹ doormaakte.

Betrokkene gaf een korte uiteenzetting van die dag: Zij kwam thuis nadat ze bij een vriendin was blijven slapen. Ze vroeg haar dochters continu dezelfde zaken, zij maakten zich zorgen. Betrokkene belde toen naar een vriend, hij was ook ongerust. Diezelfde vriend begaf zich toen naar de woning van betrokkene en ging met haar naar het ziekenhuis. Betrokkene heeft het gevoel dat haar hoofd vol was en het te veel werd toen. Kan zich niet veel herinneren van die dag, is vooral wat aan het verteld werd door omstaanders. Geen verslag.

Op **19 september 2024** werd betrokkene gezien op de raadpleging neurologie in de St-Jozefs kliniek te Izegem door Dr. A. VANHOORNE.

Het besluit luidde als volgt:

¹ TGA is een syndroom dat zich kenmerkt door een acuut optredend algeheel geheugenverlies. Er is zowel sprake van een retrograad als anterograad geheugenverlies. Retrograad geheugenverlies houdt in dat er geen herinnering is van de tijd voorafgaand aan de TGA. Anterograad geheugenverlies betekent dat het onmogelijk is om iets nieuws te leren of informatie op te slaan. Emotionele stress is een mogelijke risico-factor.

'Verhaal van transient globale amnesie gedurende enkele uren, met nadien goede recuperatie. Er is een langer bestaande context van stress en emotionaliteit, die wellicht de episodes heeft uitgelokt. Het EEG vandaag toont geen epileptische afwijkingen. MR hersenen wordt voor alle zekerheid nog gepland, maar de kans op doorgemaakte ischemie lijkt mij zeer laag. Asaflow en statine kunnen terug gestaakt worden. De recidiefkans van TGA is erg laag. Wel best jaarlijks labo bij de huisarts ter opvolging van cholesterol in primaire preventie. Ik plan een belafsprak na de MR hersenen.'

Op **30 september 2024** onderging betrokkene een MRI van de hersenen in de St-Jozefs kliniek te Izegem.

Conclusie: *'Normaal onderzoek van de hersenen. Geen ischemische letsels, ruimte-innemende processen of witte stofletsels suggestief voor encefalitis.'*

Op **3 oktober 2024** nam Dr. A. VANHOORNE, neuroloog in de St-Jozefs kliniek te Izegem contact op met betrokkene. Normale MR hersenen, wat andere mimics van TGA verder uitsluit. Patiënte werd gerustgesteld. De recidiefkans is laag.

Op **27 februari 2025** werd betrokkene gezien door de heer J. GODDYN en mevrouw I. GODDYN.- in het Psychologisch Ergologisch Expertise Centrum.

Zijn besluit luidde als volgt:

'Het onderzoek bij mevrouw Evelyne Deltour komt tot volgende vaststellingen : Het aandachtsonderzoek toont aan dat er voor de gerichte aandacht noch voor de gespreide aandacht problemen rijzen. Het concentratievermogen (hoe goed iemand zich voor langere tijd kan focussen) is verminderd. Het opslaan en ophalen van informatie verloopt vlot, zowel wat betreft het korte termijn geheugen (werkgeheugen), het lange termijn geheugen en het proceduraal geheugen (vaardigheden). De perceptie (interpretatie van zintuiglijke informatie) is deugdelijk. Op persoonlijkheidsvlak ontwaren we gevolgen, die gerelateerd kunnen worden aan de feiten van 7 januari 2024. Er is een emotionele belasting die verband houdt met het sociale coping-mechanisme. Stress-reacties met de karakteristieke stemmingsveranderingen (angst, depressie, insufficiëntie van denken en handelen) staan hierbij centraal. De risicosituatie is niet verwerkt, er is een verhoogd waakzaam wantrouwen. Dit betekent samengevat een aantasting van de levenssfeer.'

Arbeidsongeschiktheid:

In het verslag van Dr. P. VAN DE SIJPE d.d. 7 januari 2024 werd volgende periode van arbeidsongeschiktheid weerhouden:

100% 8 januari 2024 tot en met 10 januari 2024

In het verslag van Dr. E. UYTTERSROT d.d. 10 januari 2024 werd volgende periode van arbeidsongeschiktheid weerhouden:

100% 11 januari 2024 tot en met 14 januari 2024

Psychiatrie:

In het verslag van psycholoog mevrouw J. HELLIN d.d. 1 juli 2024 lezen we dat betrokkene sedert 1 februari 2024 bij haar in begeleiding is naar aanleiding van de geweldpleging door haar ex-partner in januari. Evelyne ervaart sedert het geweldincident emotionele moeilijkheden (angst, prikkelbaarheid, hyperalertheid), haar zelfbeeld is negatief en in relatie tot anderen in haar omgeving heeft zij last van verlatingsangst.

Evelyne kwam langs op volgende momenten en is op heden nog steeds in behandeling:

- 01-02-2024
- 06-02-2024
- 15-02-2024
- 19-02-2024
- 29-02-2024
- 11-03-2024
- 20-03-2024
- 08-04-2024
- 23-04-2024
- 07-05-2024
- 23-05-2024
- 06-06-2024

In het verslag van psycholoog mevrouw J. HELLIN d.d. 15 oktober 2024 lezen we dat betrokkene nog steeds in behandeling is en rond bovenstaande thema's aan het werk zijn:

Evelyne kwam langs op volgende momenten:

- 15-07-2024
- 14-07-2024
- 29-08-2024
- 12-09-2024
- 23-09-2024
- 07-10-2024

Aantal sessies kinesist

Niet van toepassing.

4. HUIDIGE KLACHTEN EN KLINISCH ONDERZOEK

Subjectieve klachten:

- Zware emotionele moeilijkheden (angst, prikkelbaarheid en hyperalert);
- Laag zelfbeeld;
- Leeft in angst, ondanks voorwaarden waaraan de dader zich momenteel aan moet houden (zoals contactverbod en onthouding alcohol) toch schrik voor wat er in de toekomst zal komen, 'wat over vier jaar'.
 - o De dader lijdt aan een bipolaire stoornis en kent een verleden van alcohol- en middelenmisbruik, betrokkene heeft schrik, gezien hij zeer onvoorspelbaar is.
 - o Hij leeft naar eigen zeggen in wrok, de scheiding is reeds elf jaar geleden, waarvan de dader reeds vijf à zes jaar een vaste partner heeft;
 - o De dader woont dichtbij. Ze zal op de parking van de winkels en tussen de *rayons* bijvoorbeeld steeds kijken of hij niet aanwezig is;
 - o Veel rustiger wanneer ze weet dat hij er niet is, bijvoorbeeld toen hij met de kinderen in Parijs was;
- Verlatingsangst, schrik om mensen te verliezen omdat ze niet goed genoeg doet (had dit voor de feiten niet);
- Moeilijkheden met geheugen;
- Moeilijk slapen;
- Nachtmerries, droomt soms dat hij terug in haar huis staat;
- Lange concentratie moeilijk. Zij kan hierdoor haar job moeilijker uitoefenen, kost haar meer moeite. Hierdoor is betrokkene ook vaker moe wanneer ze thuis komt na het werk. Gelukkig wel goede collega's die haar helpen;
- Argwanend;
- Betrokkene gaat sedert de feiten gebukt onder zeer veel stress;
- Heeft schrik om de dader nog kwader te maken, vreest voor meer agressie dan;
- Fysiek geen letsels.

4.1. KLINISCH ONDERZOEK

Algemeen

De procedure wordt uitgelegd.

Fenotype congruent met de kalenderleeftijd.

Staand

Geen asymmetrie in supraclaviculaire fossae.
Positie van het hoofd: normaal.
Prominentie doornuitsteeksel C7: normaal.
Schouderhoogte en reliëf schouderbladen: gelijk links en rechts.
Het reliëf van de doornuitsteeksels: normaal.
Cervicale en lumbale lordose: normaal.
Er is geen dorsale kyphose.
Symmetrie van de repaires ter hoogte van het bekken en de tailedriehoeken.
Unipodale stand bilateraal mogelijk.

Hoofd

Visusstoornissen: isocorie, normale lichtpupilreflexen, normale oogmotiliteit, geen nystagmus, normale vingerperimetrische gezichtsvelden.
Geen drager van corrigerende glazen.
Normale mimiek en functie van de facialismusculatuur.
Geen dysfonie of dysfagie.
Geen littekens

4.1.1. Klinisch onderzoek CWZ

Flexie: afstand tot sternum is 0 cm
Extensie: normale range, volledig (kin-manubrium 20 cm)
Dextroflexie: 50°
Sinistroflexie: 50°
Rotatie naar rechts: volledig
Rotatie naar links: volledig

4.1.2. Klinisch onderzoek bovenste ledematen

De tonus van de bovenste ledematen is normaal. De kracht waarmee de verschillende bewegingen van de bovenste ledematen kunnen worden uitgevoerd, is normaal.

Beweeglijkheid van de schouder	R	L
Anteropulsie	180	180
Retropulsie	45	45
Abductie	180	180
Externe rotatie	50	50
Interne rotatie	120	120

Painful arc	afwezig	afwezig
-------------	---------	---------

Beweeglijkheid van de elleboog	R	L
Flexie	140	140
Extensie	0	0
Pronatie	75	75
Supinatie	75	75

Palmaire flexie, dorsale flexie, radiale en ulnaire deviatie: symmetrisch.

Vinger en duimen: mobiliteit symmetrisch.

Test duim-wijsvinger: bilateraal symmetrisch. Normale gevoeligheid in het
enervatiegebied van de arm- en handzenuwen bilateraal

4.1.3. Klinisch onderzoek dorsale en lumbale wervelzuil

- o Palpatie van de paravertebrale spieren is soepel, geen pijn wordt aangegeven
- o Bekloppen processus spinosi wordt niet als pijnlijk aangegeven
- o Flexie: conform leeftijd
Extensie: normale range
- o Dextroflexie: vingers reiken tot de gewrichtsspleet
Sinistroflexie: vingers reiken tot de gewrichtsspleet
- o Rotatie naar rechts: rechtstaand 90°
Rotatie naar links: rechtstaand 90°

4.1.4. Klinisch onderzoek onderste ledematen

Bij inspectie van de heupen en knieën zien we geen afwijkingen.

5. ALGEMEEN LOCOMOTORISCH ONDERZOEK

- o Inspectie:
Er is geen hyperkinesie.
Er is geen hypokinesie.
- o Staan en gaan:
Teengang, hielgang: normaal
- o Koorddansersgang: stabiele gang.
Romberg: negatief.
- o Hurken: normaal
- o Geen hypermetrie, geen dysmetrie

- o Armen:
Dysdiadochokinese: normaal.
Vingertop-neusproef: normaal.
- o Dysartrie: afwezig.

6. ALGEMEEN PSYCHIATRISCH ONDERZOEK

Tijdens ons onderzoek zien we een vrouw die coöperatief is. De concentratie is niet lang vol te houden. Het onmiddellijke geheugen is niet verminderd. Adequate verwerkingssnelheid. Executieve functies in het cognitief domein scoren goed. Normale mentale en cognitieve flexibiliteit. Normaal perceptueel-motorisch vermogen.

Zij vertoont tijdens het onderzoek wel emotionele stress, geen manie, geen onrust.

De gedachtegang is coherent en de gedachteninhoud is adequaat.

Er zijn geen hallucinaties of waandenkbeelden.

Geen paranoïde kenmerken.

Geen psychose.

Geen ADHD.

PTSS.

Posttraumatische stressstoornis cfr.DSM-V: herbeleving van een mogelijks fatale beleving, nachtmerries, sociaal geïnhibeerd.

7. VOORVERSLAG

Het voorverslag wordt overgemaakt op 17 maart 2025 met de vraag opmerkingen over te maken voor 17 april 2025.

We mochten op datum van 24 maart 2025 volgend schrijven ontvangen van Meester Stéphanie DEBEAUSAERT:

Van: stephanie@advantius.be <stephanie@advantius.be>

Verzonden: maandag 24 maart 2025 13:05

Aan: Fien <fien@lievenwostyn.be>

CC: pec@telenet.be <pec@telenet.be>; julievandenbogaerde@lexcour.be
<julievandenbogaerde@lexcour.be>

Onderwerp: Re: Fwd: DELTOUR Evelyne voorverslag

Geachte,

Bijgesloten treft u de opmerkingen aan van cliënt, dhr. FIEUW, op het voorverslag van 18.03.2025.

Ik wens u goede ontvangst.

Met vriendelijke groet,

Stéphanie DEBEAUSSAERT

Bijlage van de heer FIEUW:

Betreft: Niet akkoord met het voorverslag van 17-03-2025 - Evelyne Deltour.

Geachte,

Het verslag concludeert met de vaststelling van PTSS bij mevrouw Deltour met als gevolg een blijvende schade van 5% economisch en 5% emotioneel.

Ik ben van mening dat een second opinion noodzakelijk is en licht dit graag gestructureerd toe.

1. Objectieve waarnemingen:

Fysieke en neurologische letsels kunnen objectief worden waargenomen. Voor beide wordt aangegeven dat er geen gevolgen zijn, wat volledig wordt bevestigd door de medische onderzoeken.

Economische (blijvende) schade kan objectief worden waargenomen zoals het verlies van inkomen en/of verminderde werkcapaciteit (bijvoorbeeld verminderde werkuren of aangepast werk).

2. Waarnemingen waarbij de input van de patiënt zeer relevant is:

De psychologische gevolgen en de impact hiervan op het dagelijkse functioneren en de levenskwaliteit kunnen niet volledig objectief worden gemeten, aangezien deze symptomen gebaseerd zijn op de persoonlijke ervaringen van de patiënt. De klachten dienen bovendien in de breedst mogelijke context te worden gezien.

3. De context en feiten die in aanmerking komen voor beoordeling:

De fysieke aanval van 07-01-2024:

- De fysieke aanval op mevrouw Deltour wordt als het enige feit behandeld in het verslag. Dit wordt echter niet in verband gebracht met andere relevante factoren die de psychologische toestand van mevrouw Deltour verder kunnen verklaren.

De relatiebreuk kort na de feiten:

- Kort na de fysieke aanval was er een relatiebreuk tussen mevrouw Deltour en haar toenmalige partner.
- Mevrouw Deltour begon in november 2023 een relatie met een man met wie ze vóór het jaar 2000 ook een relatie had. Deze man trok meteen bij haar in, vroeg de echtscheiding aan bij zijn echtgenote, en samen maakten zij plannen voor de toekomst, waaronder het kopen van een nieuw huis. Dit wijst op een diepe, hernieuwde verbondenheid en gezamenlijke toekomstplannen.
- Kort na de feiten van 7 januari 2024 besloot deze man echter abrupt terug te keren naar zijn echtgenote, zonder enige uitleg of gesprek met mevrouw Deltour. Hij pakte zijn koffers en beëindigde de relatie zonder verdere communicatie. Dit verlies van een partner met wie mevrouw Deltour zulke concrete plannen had gemaakt, heeft een veel diepere emotionele impact dan een gewone relatiebreuk.
- Het verlies van de steun van deze partner, in combinatie met de traumatische ervaring van de fysieke aanval, heeft mevrouw Deltour ongetwijfeld emotioneel zwaar getroffen, wat onvoldoende wordt weerspiegeld in het verslag.

Samenvatting:

- De symptomen die aanleiding geven tot de diagnose PTSS zijn subjectief en gebaseerd op de persoonlijke ervaringen van mevrouw Deltour. Het verslag erkent geenszins dat de psychologische klachten een bredere oorzaak kunnen hebben dan alleen de fysieke aanval.
- De input van de patiënt is eenzijdig en onvolledig. Er wordt geen aandacht besteed aan de bredere context, zoals de impact van de relatiebreuk, die een belangrijke rol speelt in de huidige psychische toestand van mevrouw Deltour.
- Uitspraken in het verslag lijken overgekwalificeerd. Mevrouw Deltour meldt voortdurend in angst te leven en vreest de gevolgen na afloop van de probatie van vier jaar. Dit terwijl de probatie juist is ingesteld om de angsten van mevrouw Deltour te beperken en haar veiligheid te waarborgen. Het lijkt erop dat mevrouw Deltour een duidelijk doel heeft, namelijk het verkrijgen van een schadevergoeding, wat de objectiviteit van de diagnose zou kunnen beïnvloeden.
- De blijvende economische schade is niet gefundeerd.

a/ Het verslag vermeldt geen gedetailleerde analyse van het inkomensverlies van mevrouw Deltour, wat essentieel is voor het vaststellen van economische schade. Er wordt niet gesproken over een vergelijking tussen haar inkomen vóór en na het incident of over de mate waarin haar werkcapaciteit door de PTSS is verminderd. Een second opinion kan onderzoeken hoe haar werkvermogen door PTSS is beïnvloed, inclusief verlies van werkuren, productiviteitsvermindering of vermissen van promotiekansen.

b/ De claim van blijvende economische schade moet niet alleen gebaseerd zijn op tijdelijk verlies van inkomen, maar ook op de langdurige invloed van PTSS op het vermogen om volledig te werken. Het is belangrijk te onderzoeken of de PTSS lange-termijn gevolgen heeft voor haar carrière, inclusief carrièremogelijkheden die mogelijk worden belemmerd door de psychische schade.

c/ Het verslag vermeldt niet of er werkplek aanpassingen zijn gemaakt om de werknemer te ondersteunen na de fysieke aanval, hetgeen voor de werkgever een wettelijke plicht is. Dit kan van invloed zijn op de arbeidsongeschiktheid van mevrouw Deltour. De werkgever had mogelijk maatregelen moeten nemen (bijvoorbeeld flexibele werkuren, verlicht werk, of psychologische ondersteuning op de werkplek) om haar in staat te stellen te blijven werken. Een second opinion kan helpen bij het vaststellen of de werkgever zijn verantwoordelijkheden heeft nagekomen en hoe dit de economische schade beïnvloedt.

Gezien de bovenstaande punten verzoek ik u om een herziening van het verslag, waarbij zowel de fysieke aanval als de impact van de relatiebreuk volledig in beschouwing worden genomen en uitspraken op zijn minst kritisch worden beoordeeld.

Het zou zinvol zijn om de relatiebreuk expliciet in het verslag te betrekken, vooral omdat verlatingsangst en laag zelfbeeld typische reacties zijn op het verlies van een partner en de emotionele steun die deze biedt. Het zou nuttig zijn om een vollediger psychologisch verslag te verkrijgen waarin beide factoren (de fysieke aanval en de relatiebreuk) als gelijktijdige, elkaar versterkende invloeden op de psychologische gezondheid van mevrouw Deltour worden erkend.

Het verslag biedt geen voldoende bewijs voor het blijvend karakter van het economische verlies, aangezien het geen gedetailleerde analyse bevat van het inkomensverlies op lange termijn of de impact van PTSS op het werkvermogen van mevrouw Deltour.

Antwoord van deskundige:

1. De schade is persoonlijk en economisch. Een emotionele schade werd niet begroot.
2. Een emotioneel impact, zoals het verlaten worden door een partner, lokt eerder depressieve gevoelens uit. Dit is niet gelijk aan een bijna doodservaring met flashbacks, nachtmerries en sociaal geïnhibeerd zijn. De politiediensten stelden bloedspatten vast aan de buitenzijde van de voordeur en op de deur. De slagen en verwondingen waren zeer hevig geweest. Evelyne DELTOUR was bebloed over het gehele gezicht en was duidelijk in shock. Er werd op de romp gezeten wat de ademhaling belemmert en de dood kan veroorzaken (*burking*). Er is dus sprake van een ongewoon verschrikkelijk meemaken van een trauma.

3. Op 10 januari 2024 was er reeds een voorschrift tot psychologische hulp, opgemaakt door de huisarts Dr. Elise UYTTERSROT. Begeleiding vanaf 1 februari 2024.
4. Het concentratievermogen is verminderd. Lange concentratie moeilijk. Zij vergeet veel. Klanten maken haar daar soms attent op. Zij kan hierdoor haar job moeilijker uitoefenen, het kost haar meer moeite. Hierdoor is betrokkene ook vaker moe wanneer ze thuis komt na het werk. Er zijn de stress-reacties met karakteristieke stemmingsveranderingen zoals angst, depressie, insufficiëntie van denken en handelen. Dit alles vermindert de werkcapaciteit. Deze stoornissen geven een vermindering van de economische waarde op de arbeidsmarkt, er is de noodzaak om grotere inspanningen te doen en men moet beroep doen op goede collega's als die er al zijn. Dit heeft een impact op het werkvermogen.
5. Uit de opmerkingen van de heer FIEUW blijkt dat hij de zaken onterecht minimaliseert met een totaal gebrek aan ziekte-inzicht tot de feiten.
6. Er dient geen *second opinion* gevraagd te worden. Er worden door de heer FIEUW geen nieuwe elementen aangebracht, er is geen advies/verslag van een domeindeskundige. De uitnodiging tot de expertisезitting gebeurde tegensprekelijk.² Het verslag werd kritisch opgesteld.
7. Uit het deskundigenonderzoek bleek niet dat mevrouw uit is op een grote compensatie. Integendeel, zij was bang dat dit de woede van de agressor zou vergroten.
8. Verder is het de rechtbank die de bewijswaarde en de bewijskracht van het verslag zal bepalen.

Schrijven dd. **3 april 2025** van de heer GODDYN:

² Ik verwijs hiervoor naar de niet-tegensprekelijke overgemaakte email van de heer FIEUW van 30 november 2024:

Van: Jan Fieuw (Docc) <jan.fieuw@docc.be>

Verzonden: zaterdag 30 november 2024 11:20

Aan: info@lievenwostyn.be <info@lievenwostyn.be>

Onderwerp: Uw referentie 24994

Beste dokter,

Betreffende tegenpartij,

DELTOUR Evelyne, Jozef Delbaerestraat 1, 8800 Roeselare.

Ik ontving uw brief, gedateerd 28/11/2024.

Ik begrijp uw vraag niet betreffende het beroep doen op een raadsgeneesheer.

Ik veronderstel dat u het causaal verband zal onderzoeken tussen de geweldpleging en de psychische toestand van Evelyne?

Kan ik eerst uw conclusies afwachten en hier later over beslissen?

Met vriendelijke groeten,

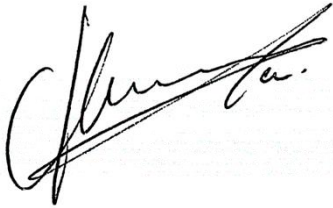
Jan Fieuw

Geachte Dokter,

Betreft : Gerechtelijke expertise Deltour Evelyne uw ref. 24994

Na lezing van uw voorverslag en na telefonisch contact met mevrouw Deltour op heden heb ik geen opmerkingen te sturen.

Met voorname hoogachting,



Schrijven dd. **8 april 2025** van de heer GODDYN:

Van: jan goddyn <pec@telenet.be>

Verzonden: dinsdag 8 april 2025 11:22

Aan: Fien <fien@lievenwostyn.be>

CC: jan goddyn <pec@telenet.be>

Onderwerp: addendum op antwoord bij voorverslag DELTOUR/FIEUW (referentie 24994)

Geachte dokter,

Er zijn geen opmerkingen, maar bij lezing zie ik enkele schoonheidsfoutjes

- op p. 15 staat vermeld dat op 15 augustus 2024 Evelyne Deltour 'haar dochters' continu dezelfde zaken vroeg. Dit zou moeten worden aangepast naar 'haar dochter en zoon'
- op p. 12 van het voorverslag staat bij de subjectieve klachten vermeld dat Evelyne Deltour sinds '11 jaar' gescheiden is. Dit dient '12 jaar' te zijn.
- Ons inziens sloop er een foutief jaartal bij de besluiten van de TPO en THO:
 - 100% op 15 augustus **2024**
 - 20 % van 16 augustus **2024** t.e.m. 30 september 2024

Hoogachtend,

Jan Goddyn

Antwoord van deskundige:

Inderdaad. Excuses. Wordt gecorrigeerd.

8. BESPREKING en BESLUIT:

Volgend **advies** kan verleend worden en dit naar aanleiding van de feiten van **DELTOUR Evelyne** haar overkomen op **7 januari 2024**:

Hoofdwonde gehecht. Geen litteken zichtbaar.

Posttraumatisch stresssyndroom: cfr.DSM-V: herbeleving van een mogelijks fatale beleving, nachtmerries, sociaal geïnhibeerd. Zie Europese schaal voor de beoordeling van aantastingen van de fysieke en psychische integriteit. B) Psychiatrie b) traumatische neuroses (posttraumatische stress) fobische angstmanifestaties met ontwijkend gedrag en herhalingssyndroom (3 à 8 %). Weerslag op het werk.

Consolidatiedatum:

7 januari 2025

Blijvende economische ongeschiktheid 5 %

Blijvende persoonlijke ongeschiktheid 5 %

Blijvende huishoudelijke ongeschiktheid 0 %

Tijdelijke economische ongeschiktheid:

100%	8 januari 2024 tot en met 14 januari 2024
20 %	15 januari 2024 tot en met 30 augustus 2024
10 %	1 september 2024 tot en met 6 januari 2025

Tijdelijke persoonlijke ongeschiktheid:

100%	8 januari 2024
20 %	9 januari 2024 tot en met 14 augustus 2024
100 %	15 augustus 2024
20 %	16 augustus 2024 tot en met 30 september 2024
10 %	1 oktober tot en met 6 januari 2025

Tijdelijke huishoudelijke ongeschiktheid:

100%	8 januari 2024
20 %	9 januari 2024 tot en met 14 augustus 2024

100 %	15 augustus 2024
20 %	16 augustus 2024 tot en met 30 september 2024
5 %	1 oktober tot en met 6 januari 2025

Behandeling na de consolidatiedatum: 15 sessies cognitieve gedragstherapie en escitalopram en trazodone voor 3 jaar op voorschrift/factuur.

Voorbehoudende voor de toekomst: geen

Geen genoegschade

Geen hulp van derden

Geen seksuele schade

Esthetische schade : schaal van 0 op 7

"Ik zweer dat ik mijn taak naar eer en geweten, nauwgezet en eerlijk heb vervuld."

Dit verslag telt 22 genummerde bladzijden.

Aalter, 12 mei 2025

Dr. Lieven WOSTYN

EXP2165726
Master in de rechten
Specialist in de medische expertise en verzekeringsgeneeskunde
EXP2165726
BAP UAntwerpen/Fellow Law and Criminology VUB
Consulent Centrum voor gerechtelijke geneeskunde UZA